

1

CONTROL EN SALUD ENTRE LOS 2 Y 5 AÑOS

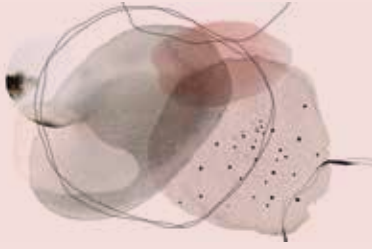
// DRA. ROMINA ANDREA VALERIO

Médica Especialista en Pediatría UBA - SAP.

Fellow de Pediatría Ambulatoria Hospital Nacional. Prof. A. Posadas.

Secretaria del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria - SAP.

Docente Adscripta de la UBA. Profesora Adjunta en la Universidad Nacional de Hurlingham.



LUCA, 2 AÑOS Y 3 MESES

Acuden a la consulta los padres de Luca. Comentan que estaban de compras con su hijo en el supermercado, y él vio una pelota. La pidió varias veces y luego de esa insistencia le dijeron que NO. De repente, Luca hizo un berrinche fuerte, se tiró al piso, pataleaba, gritaba y lloraba. Los padres no sabían cómo calmarlo, y decidieron comprarla por vergüenza. Comentan que estas situaciones son cada vez más frecuentes y angustian.

a) ¿Hasta qué edad pueden desencadenarse los berrinches?

b) ¿Qué información es importante de la anamnesis?

c) ¿Qué sugerencias podemos brindar a los padres ante un berrinche?

d) ¿Se pueden prevenir?

**Después de finalizar la lectura del capítulo,
compare sus respuestas con las que figuran en Clave de Respuestas.**

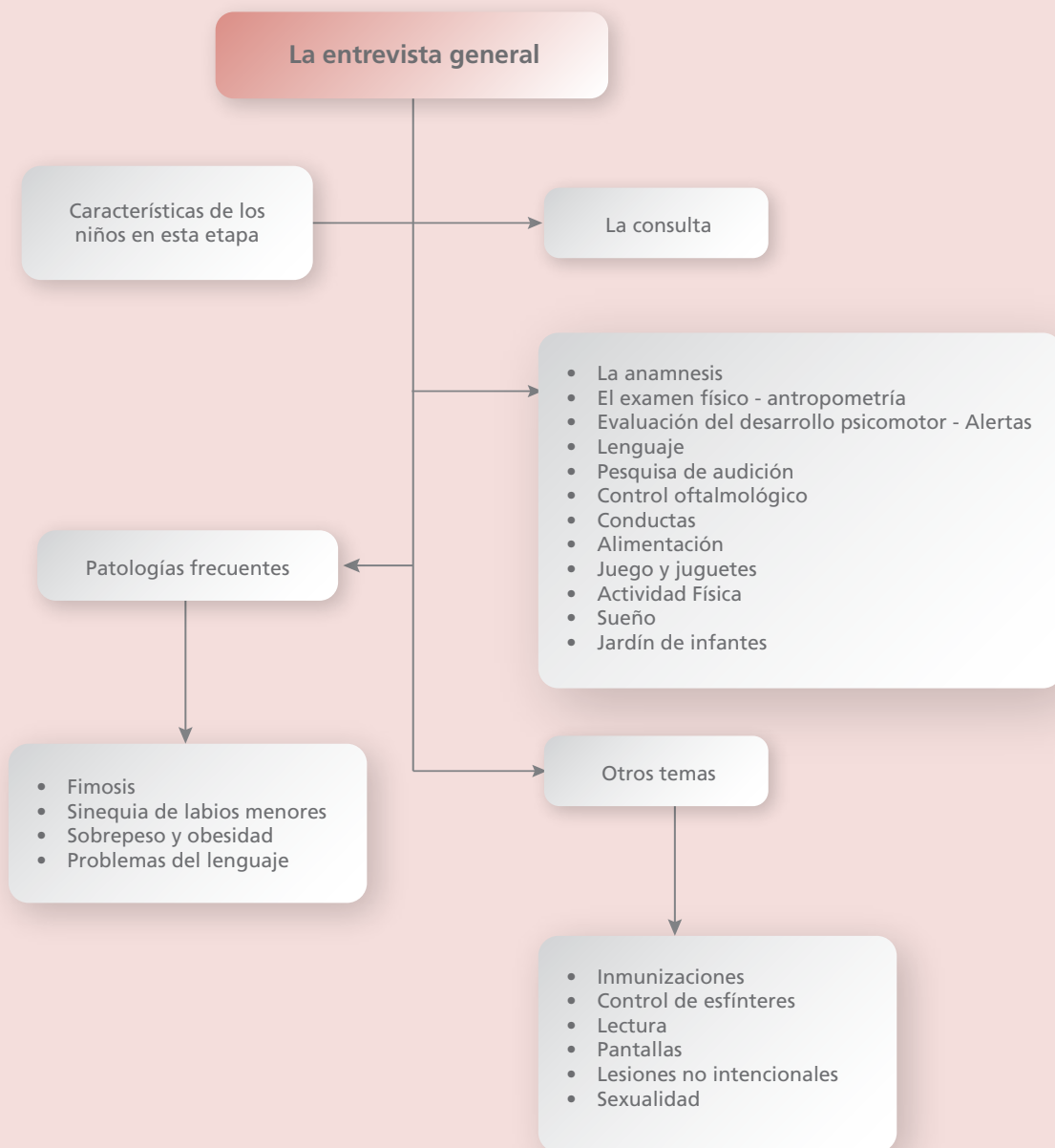


OBJETIVOS

- ◆ Valorar la importancia del control en salud para recomendar medidas de promoción y protección de la salud, brindar acompañamiento a las familias y cuidadores en relación a la crianza, el crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas.
- ◆ Reconocer al niño como el protagonista de la consulta.
- ◆ Identificar las acciones generales a implementar durante la consulta, así como los aspectos particulares y evaluaciones específicas que demande cada niño según sus necesidades individuales.
- ◆ Reconocer la importancia de evaluar durante la consulta las características del niño —como su comportamiento, nivel de autonomía, lenguaje, exploración y juego— junto con la actitud de sus cuidadores, para obtener una visión integral de su desarrollo y de su entorno cercano.
- ◆ Destacar la importancia de la supervisión del desarrollo infantil en cada consulta, como medida de promoción integral de la salud de las infancias.
- ◆ Conocer las señales de alerta en los diferentes aspectos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de niños y niñas para intervenir oportunamente.
- ◆ Considerar la consulta pediátrica como una oportunidad para promover hábitos saludables en las infancias y sus familias.



ESQUEMA DE CONTENIDOS



INTRODUCCIÓN

Los controles en salud en niños, niñas y adolescentes son de vital importancia ya que además de brindar el acceso a la salud, los pediatras podemos recomendar medidas de promoción y protección de la salud, brindar acompañamiento a las familias y cuidadores en relación a la crianza, el crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas.

Esta supervisión de la salud tiene como objetivos principales:

- Promover hábitos de vida saludables.
- Prevenir enfermedades.
- Detectar situaciones de vulnerabilidad.
- Intervenir en forma oportuna.

Desde una mirada amplia e integral, centrada en cada niño o niña y sus familias, en un contexto cultural, histórico y social en el que viven.

Entendiendo a la salud como derecho, es importante garantizar su ejercicio pleno priorizando la realización de estos controles, brindando un espacio de contención y escucha empática, de sostén, que genere y fortalezca un vínculo entre niños, familias y cuidadores y el equipo de salud.

En este capítulo se abordan los diferentes aspectos a tener en cuenta en el control en salud de 2 a 5 años.

Utilizaremos la palabra niño para referirnos a toda persona de esa edad incluyendo a todas las diversidades e identidades, para lograr una lectura simple en sus contenidos y su interpretación.

LA ENTREVISTA GENERAL

En cada control se llevan a cabo diferentes **acciones que son generales** en la consulta pediátrica contextualizada:

- Revisión de la historia clínica.
- Realización de una buena anamnesis.
- Examen físico completo.

Pero también cada control tiene **aspectos y evaluaciones específicas** según cada etapa del niño en relación a:

- Su crecimiento y desarrollo.
- Situaciones especiales que estén atravesando en el momento.

Es una oportunidad valiosa para **entender el contexto en el que sucede la consulta** para:

- Detectar situaciones de riesgo individual o familiar.
- Conocer aspectos particulares de la familia, su historia, si están atravesando alguna crisis, y reconocer las fortalezas.

La **comunicación** debe ser efectiva, dirigirnos con lenguaje claro y sencillo, en un ambiente agradable, con tiempo disponible para una escucha atenta, realizar sugerencias y recomendaciones pertinentes, respetando los diferentes estilos de crianza, los deseos y el bagaje cultural de cada familia **sin juzgar**, y basados en la mejor evidencia científica.

Es importante considerar que **el protagonista de la consulta es el niño**. Por eso, se recomienda llamarlos por su nombre, dar la oportunidad para que se expresen, explicarles en ese momento lo que va a suceder para abordar la consulta desde el respeto y la empatía, y sin temor.

La frecuencia de los controles recomendada a estas edades va a depender de las necesidades de cada niño/a, sus padres/cuidadores, el contexto social y de su comunidad.

La última recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría establece una frecuencia mínima de controles según las diferentes edades:

- Entre 2 y 3 años - cuatrimestrales.
- Entre 3 y 5 años - semestrales.

Es fundamental valorar en cada caso el riesgo bio-psico-socio-ambiental del niño para promover consultas más frecuentes de ser necesario.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS EN ESTA ETAPA

- A partir de los 2 años de edad los niños van desarrollando más autonomía e independencia.
- Su lenguaje es más rico y fluido.
- El crecimiento físico cambia y se hace más lento a partir de los 3-4 años. El cuerpo va adquiriendo una forma diferente ya que el aumento de peso también es menor.
- Hay una disminución del egocentrismo, y mayor deseo de interactuar con otros niños y adultos, lo que favorece la socialización.
- Van desarrollando diferentes habilidades psicomotoras que le permiten adquirir hábitos de higiene, alimentación y sueño saludables.
- En esta independencia que van adquiriendo, aparece en forma más marcada el oposicionismo y los berrinches como forma de expresión de sus propias opiniones y deseos. Comprenden el "NO" como límite puesto por sus cuidadores, que muchas veces se contrapone a sus deseos o necesidades, generando frustración. Este conflicto entre el propio deseo y el deseo de sus cuidadores provoca "enojos" y/o estallidos emocionales o "berrinches". Estos son comportamientos

normales en el desarrollo de los niños entre los 18 meses y los 3 años de edad aproximadamente. En algunos son más frecuentes que otros, y empeoran cuando están cansados, con hambre o con algún malestar.

- En el niño pequeño la regulación es externa, a través de los cuidadores que lo ayudan a transformar y apaciguar sus emociones negativas. A medida que crecen y se desarrollan van procesando y modulando los estímulos sensoriales, mejorando el autocontrol. Así, los berrinches van siendo cada vez menos frecuentes (alrededor de los 3 años y medio de edad en la mayoría de los niños ya desaparecen). Es importante considerar que hay factores físicos, neurológicos, genéticos, emocionales, y/o del vínculo con cuidadores, etc. pueden generar alteraciones en esta autorregulación.
- En esta etapa también se observan nuevos logros como una mayor capacidad de pensamiento lógico, desarrollo de la memoria, mayor capacidad para organizar conductas complejas asociada al desarrollo de las funciones ejecutivas y cognitivas superiores.
- En la etapa preescolar surge el interés por compartir con sus pares y la exploración del mundo físico. La actividad física es de gran importancia, y se reduce la necesidad de sueño. También, se adquiere el control de esfínteres y se afianzan hábitos saludables.

LA CONSULTA

Los siguientes aspectos que deben ser incluidos en la consulta con niños de estas edades:

- ✓ Anamnesis.
- ✓ Examen físico – antropometría.
- ✓ Evaluación del desarrollo psicomotor – Instrumentos y alertas.
- ✓ Lenguaje y la pesquisa auditiva.
- ✓ Control oftalmológico.
- ✓ Conductas.
- ✓ Alimentación – lactancia – suplementos.
- ✓ Juego y los juguetes.
- ✓ Actividad física.
- ✓ Sueño.
- ✓ Jardín de infantes.

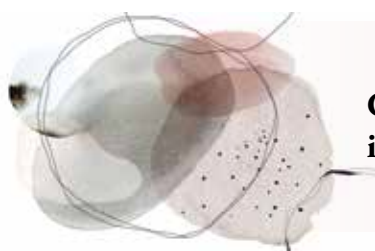
Anamnesis

Durante la entrevista sobre todo si es la primera vez, se debe investigar sobre:

- Antecedentes de salud perinatales, embarazo y parto, edad gestacional, peso, etc.
- Antecedentes personales: enfermedades previas y actuales, crónicas, tratamientos recibidos, hospitalizaciones. Si realizó evaluaciones médicas por especialistas y sus motivos.
- Estudios complementarios realizados.

- Antecedentes médicos familiares de importancia.
- Factores de riesgo ambiental. Vivienda, zona. Red de cloacas. Agua corriente. ¿Fábricas? ¿Exposición a humo y tabaco? Mascotas.
- Trayectoria del desarrollo hasta el momento. Realizar una Historia Clínica del desarrollo.
- Inmunizaciones, se controlarán las vacunas según calendario oficial.
- Alimentación: tipo de alimentos, cantidad, frecuencia. Restricciones. Si usa mamadera, chupete. Comensalidad. El momento de comer.
- Lactancia. Destete.
- Presencia de pantallas. Juego. Actividad física. Otras actividades como música, teatro, pintura, etc.
- Higiene bucal. Consulta al odontopediatra.
- Sueño: rutina a la hora de dormir, horas de sueño nocturno, siestas. Dónde duerme. Ver si hay colecho y/o cohabitación.
- ¿Asiste al jardín? Si no asiste, preguntar quién se queda a su cuidado la mayor parte del tiempo, si tiene oportunidad de socializar con otros niños de su edad. Si tienen algún jardín en vista. Es una oportunidad para fomentar que comiencen a buscarlo para la sala de 4 años, que es obligatoria. En caso de que ya asista, ver cómo transcurre ese momento. Tipo de escolaridad. Si hay dificultades. Amistades. Informes del jardín.
- Si tuvo interurrencias desde el último control.
- Situaciones nuevas o inesperadas que puede estar atravesando la familia, como mudanzas, fallecimientos, violencia, adicciones etc.
- Dudas o preguntas de sus cuidadores. Preocupaciones. Logros o dificultades.
- Red familiar, si hay contención, si vienen de otras ciudades o provincias, culturas y creencias, etc.

Durante la entrevista iremos observando muchas características del niño: comportamiento, nivel de autonomía, lenguaje, si explora, cómo juega (imprescindible tener algún juguete). Podemos ofrecer un papel y lápices o crayones para invitarlos a dibujar, y así podremos evaluar su dibujo. Ver la actitud de sus cuidadores, como es el trato, etc.



Conocer cómo es un día de vida del niño nos aporta mucha información.

Examen físico

Se realizará un examen físico completo, con una evaluación integral de todos los aparatos y sistemas, con la presencia del adulto acompañante.

Inspección general. Aspecto general. Signos vitales.

Piel	Coloración de piel y mucosas. Presencia de dismorfias o anomalías congénitas, cicatrices, angiomas, nevos, máculas café con leche, hipo o acrómicas. Ante lesiones describir su aspecto, tamaño y localización. Descartar dermatitis de diversas causas. Ausencia de olor axilar. Alopecia en el cuero cabelludo. Pediculosis.
Boca	Examinar labios, mucosa bucal y cara interna de mejillas, dientes, encías, lengua y piso de boca. Dentición temporal. Estado de las piezas dentarias. Oclusión. Detectar presencia de caries. Durante el segundo año van apareciendo los primeros molares, los caninos y los segundos molares. La dentición primaria debe estar completa antes de los 3 años, y la caída de los mismos suele ocurrir en período escolar (6 años en adelante), siendo reemplazada por la dentición permanente.
Cuello	Simetrías. Masas palpables. Presencia de adenopatías y características. Ante hallazgo de adenopatías se deben buscar otras, y/o signos clínicos de compromiso hematológico (palidez o petequias o equimosis) y hepatomegalia o esplenomegalia.
Tórax	Inspección. Forma. Respiración. Auscultación cardíaca y pulmonar. Ausencia de botón mamario. Palpación de pulsos periféricos. A partir de los 3 años (sin antecedentes HTA): Toma de presión arterial con manguito adecuado. Debe realizarse de rutina con el fin de identificar causas secundarias de hipertensión arterial.
Abdomen	Descartar masas y visceromegalias.
Región genital	Visualización de región perianal, buscar huevos o parásitos, si hay materia fecal escurrida o se palpa un fecaloma, o presencia de lesiones. Niños: presencia de testículos en el escroto, ausencia de líquido libre en escroto, fimosis, adherencias, descartar inflamación del glande, ver la ubicación anatómica de uretra y presencia de secreción uretral purulenta, descartar masas palpables inguinales o escrotales. Preguntar por el chorro miccional. Niñas: ver normalidad anatómica, descartar sinequias y secreción anormal vaginal. Vulvovaginitis.
Examen neurológico, ortopédico y locomotor	Ver la postura, longitud de los miembros, marcha, en especial alteraciones en la movilización de extremidades. Talo valgo, marcha en puntas de pie. Genu valgo simétrico fisiológico. Pie plano reductible fisiológico, ver si hay dolor o es fijo. Reflejos. Maniobra de Adams.
Ojos	Evaluar la simetría de las pupilas con el Test de Hirschberg. Observar si hay secreción ocular o epífora. Evaluación oftalmológica básica. (Ver apartado Pesquisas Oftalmológicas).
Oídos	Realizar otoscopia. Buscar dismorfias, fístulas preauriculares, etc.

Evaluación del **lenguaje** dentro de los hitos del desarrollo: expresión y comprensión. Pronunciación. (Ver apartado Lenguaje-Comunicación y Pesquisas).

Tener en cuenta **lesiones que puedan ser sospechosas de maltrato infantil**, por ejemplo, lesiones en piel con formas específicas (cinturón, etc.), hematomas y su ubicación, quemaduras etc.

Se realizará la **antropometría** para valorar en forma objetiva y estandarizada el crecimiento físico y la nutrición, a través de la medición de **peso/edad, talla/edad e IMC/edad para cada sexo, y sus percentilos**. Se analizarán mediciones únicas para ver parámetros estáticos, y también se tomarán mediciones previas para analizar velocidades de crecimiento, y comparar los datos obtenidos según tablas de referencia. Se utilizan como referencia las curvas Estándar de OMS 2006 para niños desde el nacimiento hasta los 5 años y las nacionales de la Guía para la evaluación del crecimiento Físico, SAP, 2021.

Es fundamental graficar las medidas antropométricas que se obtienen en cada control para confeccionar las curvas de peso y talla para edad y sexo.

Sabemos que en los dos primeros años el 75% de los niños crece adecuándose a carriles según su carga genética familiar. Por esta característica del crecimiento después de los 2 años podemos comparar la talla de las niñas/os con la de sus padres biológicos. Un cambio de carril de percentilos después de los 2 años es considerado una señal de alerta. Se recomienda volver a medir o pesar para corroborar datos y analizarlo en contexto.

Evaluación del desarrollo psicomotor

El desarrollo psicomotor contempla aspectos del área social, la cognición, el lenguaje y la comunicación, y la motricidad fina y gruesa.

La **supervisión del neurodesarrollo** es un paso importante que debe realizarse en cada consulta pediátrica en salud. Detectar signos de alarma y/o problemas que impliquen una intervención oportuna y precoz más allá de un diagnóstico, es esencial para lograr una mejor calidad de vida de los niños y sus familias.

En nuestro país existen diferentes **herramientas para supervisar el neurodesarrollo infantil**. Algunas son **de pesquisa**, otras **de observación**. No son diagnósticas, sino que pueden dar resultados sospechosos de algún problema del desarrollo, lo que implica profundizar esta evaluación según las particularidades y contextos de cada niño/a.

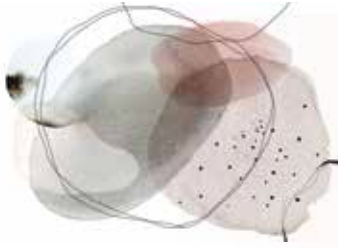
Existen instrumentos para una **observación sistematizada**, por ejemplo:

- El **IODI** - Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil.
- Cuestionarios que pueden ser realizados por los padres, con una eficacia similar a los instrumentos de pesquisa de tipo observacional, por ejemplo, cuestionario **PRE-PRUNAPE**.
- El **ASQ-3** o Cuestionario de Edades y Etapas, tercera edición (Ages and Stages Questionnaire).

Hasta el momento, en nuestro país, la Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE, Lejarraga et. al.) es el único instrumento de pesquisa de problemas del desarrollo no aparentes, que está validado. Se administra hasta los seis años de edad. En esta prueba están definidos los diferentes percentilos de edades de cumplimiento para 79 pautas de desarrollo en niños argentinos, o sea, las edades entre las cuales es esperable la adquisición de determinada pauta.

La recomendación de las Guías para la supervisión de la salud de niños y adolescentes de la SAP sugiere **utilizar una prueba de pesquisa de desarrollo general como mínimo, 2 veces en los primeros 5 años de vida del niño, por personal entrenado para ello:**

- 1) A los 18 y a los 36 meses en niños de bajo riesgo.
- 2) Una vez por año antes de los 6 años en niños de alto riesgo.
- 3) En cualquier niño cuando haya signos de alarma.



Las preocupaciones de los padres sobre el desarrollo de sus hijos deben ser especialmente consideradas, ya que suelen ser los primeros en sospechar la presencia de un problema.

A su vez, poder diferenciarlo de las expectativas de los padres en relación a los hitos que van logrando sus hijos.

La supervisión del desarrollo en cada consulta es tarea fundamental del pediatra como medida de promoción de la salud integral de las infancias.

Tabla 1. Señales de ALERTA en el desarrollo infantil por edades

2 AÑOS	No dice palabras o tiene un repertorio pobre, no se comunica con gestos, tiene pobre interacción social, no tiene atención conjunta. No hace garabato. No tiene juego simbólico. No realiza órdenes de 2 pasos.
3 AÑOS	Pobre intercambio social. Lenguaje ininteligible, o sin intento comunicativo. Disfluencia de más de 3 meses. Berrinches intensos y persistentes, marcada ansiedad social.
4 AÑOS	Marcada oposición y dificultades en la conducta. Dislalias múltiples. Aislamiento, poca interacción social. No juega con otros. No hay control de esfínteres.
5 AÑOS	Lenguaje pobre, dislalias. No reconoce colores. Poca interacción social. Marcada hiperactividad, dificultades en la conducta. Mala adaptación al jardín preescolar.

Lenguaje y pesquisa de audición

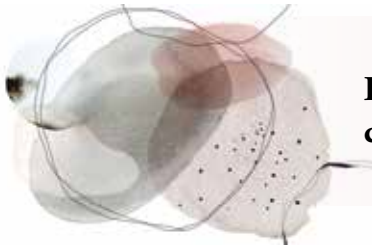
A medida que crecen y se desarrollan van adquiriendo recursos lingüísticos (verbal), y no lingüísticos (gestual) para comunicarse. Si hablamos especialmente del lenguaje, hay que tener en cuenta el de expresión (palabras, frases, etc.) y el de comprensión.

Para ello se necesita de la audición, del procesamiento cognitivo en relación con el exterior (personas y objetos), y de mecanismos efectores motores y psicomotores.

Hay que tener en cuenta que los niños con un desarrollo típico comprenden más palabras de las que pueden decir, sobre todo a esta edad.

Otro aspecto importante a evaluar es la socialización, que va de la mano con la comunicación: la respuesta al llamado por su nombre, el interés por interactuar con otras personas, la atención, la mirada a los ojos, el saludo, como responde al acercamiento de pares y de adultos, entre otros aspectos.

El informe escolar es una herramienta útil en este sentido, así como el momento de la consulta pediátrica.



La audición es fundamental para el neurodesarrollo y la comunicación.

Evaluación auditiva

Según la OMS, 5 de cada 1.000 nacidos vivos padecen algún grado de hipoacusia, y 1-3 de cada 1.000 RN vivos presentan hipoacusia neurosensorial moderada a severa, o sea, es frecuente. La mayoría se presenta en el periodo neonatal. En nuestro país se realiza una pesquisa al nacer, en forma obligatoria, según el Programa Nacional de Detección temprana y Atención de la Hipoacusia, Ley Nacional 25.415/2001.

La etapa más sensible del desarrollo son los primeros 24 meses, donde se detectan las hipoacusias profundas.

El desafío que se nos presenta es con las hipoacusias leves o moderadas, cuyo diagnóstico es generalmente a los 36 meses, cuando son evidentes las dificultades en el lenguaje de comprensión y expresión. Diversos estudios muestran que el déficit auditivo leve o incluso unilateral puede asociarse a problemas de lenguaje, habilidades comunicacionales, cognitivas, conductuales, socioemocionales y dificultades escolares.

Interrogar y detectar la presencia de **factores de riesgo** en los antecedentes como:

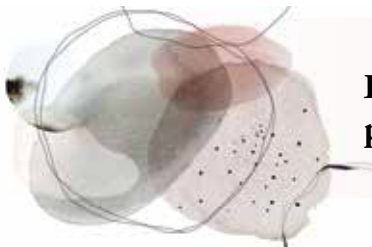
- ✓ Historia familiar de hipoacusia.
- ✓ Infección intrauterina por CMV, Rubeola, Sífilis, Herpes o Toxoplasmosis.
- ✓ Peso al nacer menor de 1.500 g.
- ✓ Hiperbilirrubinemia grave.
- ✓ Antecedentes de medicación ototóxica.
- ✓ Meningitis bacteriana.
- ✓ ARM más de 5 días.
- ✓ Hipoxia perinatal.
- ✓ Presencia de anomalías craneofaciales y dismorfias sindrómicas, etc.

La Academia Americana de Pediatría recomienda hacer pruebas de audición más detalladas a los 4, 5, 6, 8 y 10 años, y en cada control en salud estar atento a los factores de riesgo de sospecha de hipoacusia mencionados. También propone que en la supervisión de salud de lactantes y pre-escolares se realice:

- Vigilancia periódica de los hitos del desarrollo, que incluya el lenguaje y su progresión.
- Un examen físico completo evaluando alteraciones cabeza y cuello e incluyendo otoscopia.
- Pruebas auditivas apropiadas según la edad, en un ambiente tranquilo y sin distractores.
- Siempre considerar la opinión de padres, cuidadores y docentes.

Si tiene factores de riesgo y la pesquisa neonatal (OEA) pasa, el seguimiento es cada 6 meses hasta los 3 años de vida, con evaluación del lenguaje y la conducta ante estímulos sonoros en cada control y estudios audiológicos.

Estudios que se pueden realizar: Otoemisiones acústicas, Audiometría (la convencional a partir de los 5 años, por juego en los más chicos). Impedanciometría. Timpanometría. Potenciales Evocados Auditivos con determinación de umbrales.



El diagnóstico precoz de la hipoacusia infantil mejora el pronóstico cuanto más temprano se inicie el tratamiento.

Control oftalmológico

Según la OMS, en el mundo hay 7,5 millones de niños en edad escolar portadores de algún tipo de deficiencia visual y sólo el 25% presenta síntomas.

Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y la SAP, se recomienda realizar **controles oftalmológicos en las siguientes edades:**

- ✓ Recién nacido: pesquisa con reflejo rojo.
- ✓ A los 6 meses.
- ✓ A los 12 meses.
- ✓ A los 3 años.
- ✓ A los 5 años.
- ✓ Luego cada 1 o 2 años según antecedentes personales y/o familiares.

Las pesquisas de alteraciones visuales realizadas antes del ingreso escolar permiten detectar precozmente patologías que requieren tratamiento, brindando mayores oportunidades. La Academia Americana de Oftalmología Pediátrica recomienda que en cada consulta pediátrica se realice una evaluación de la vista, con las siguientes pruebas en mayores de un año:

- Inspección externa del ojo. Fijación y seguimiento en cada ojo.
- Reflejo corneal a la luz - Test de Hirschberg (evaluación de alineación de los ojos).
- Agudeza visual: Se recomienda a partir de los 3 años. Se realiza inicialmente con cartillas de figuras, luego la prueba de la letra E y a partir de los 5 años con la cartilla de Snellen.
- La visión de colores puede evaluarse a partir de los 4 o 5 años. Test de Ishihara (detecta daltonismo).

Signos y síntomas de problemas visuales - ALERTAS

- Dificultad en la visión a corta, mediana o larga distancia.
- Se acerca demasiado al televisor, o se acercan mucho los objetos para verlos.
- Desvía un ojo de forma permanente o intermitente.
- Baja coordinación ojos-mano, como dificultad al atrapar una pelota.

Se **recomienda la derivación para evaluación oftalmológica** completa si en el examen inicial hay hallazgos sugestivos, y en los niños/as con factores de riesgo:

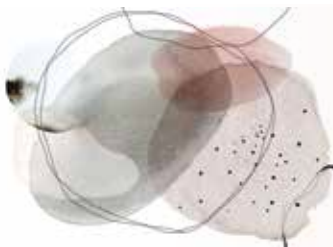
- ✓ Prematurez.
- ✓ Antecedentes familiares de catarata congénita.
- ✓ Glaucoma congénito.
- ✓ Retinoblastoma.
- ✓ Enfermedades metabólicas o genéticas, etc.

El Estado, a través de políticas públicas, debería garantizar la accesibilidad y equidad en las consultas oftalmológicas. Sólo en aquellos lugares en que esto no esté garantizado se deberá capacitar a los equipos de salud para realizar una evaluación, detectar déficits visuales y realizar las interconsultas especializadas.

La conducta

Es importante considerar varios factores, siendo el social y sobre todo el vínculo primario con cuidadores y/o la familia el principal. Este factor clave sienta las bases de la socialización, a través del afecto, protección, solidaridad, apoyo físico y emocional, y forja a las infancias en las normas y valores para vivir en sociedad.

Hay además múltiples aspectos que están interrelacionados, como el temperamento de cada niño/a, como procesa los estímulos sensoriales, la autorregulación, entre otros.



La autorregulación es la capacidad de una persona para adecuar su conducta según las demandas de situaciones específicas, y se va adquiriendo a medida que van logrando independencia.

Los niños con los siguientes antecedentes tienen **mayor riesgo** de presentar dificultades de autorregulación:

- ✓ Prematurez.
- ✓ Enfermedades genéticas.
- ✓ Exposición perinatal a tóxicos.
- ✓ Infecciones del SNC.

Entre los problemas más frecuentes en esta etapa se encuentran la oposición para seguir las normas, los miedos excesivos y las dificultades con la alimentación y el control de esfínteres. Indagar acerca de los sentimientos que está atravesando ese niño, como en el entorno y que medidas toman sus cuidadores en estas situaciones, es clave para abordarlo.

Alimentación

Sabemos que los primeros años de vida son un período crítico para desarrollar el máximo potencial intelectual y físico de las personas, y para ello es indispensable también una alimentación adecuada, en un entorno saludable. Elegir alimentos saludables desde pequeños es fundamental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la elección de alimentos no adecuados desde edades tempranas lleva a una **“programación metabólica temprana”** que, a largo plazo, si este hábito se sostiene, puede generar diversas enfermedades como: caries dental, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad, alergias y cáncer aun en la edad adulta.

Además, la alimentación es considerada un acto social, multidimensional, que implica una elección, una preparación y compartir con..., por lo tanto, está ligada a la cultura y creencias de cada familia, generando vincularidad y sentido de pertenencia.

En esta etapa es esperable que coman menos. Comparten la mesa con el resto de la familia, y puede suceder que no quieran sentarse para deambular, y/o que elijan algunos alimentos en vez de otros. Se aconseja establecer límites de cuidado en forma respetuosa.

Según las **normas del Ministerio de Salud de la Nación y la SAP se aconseja:**

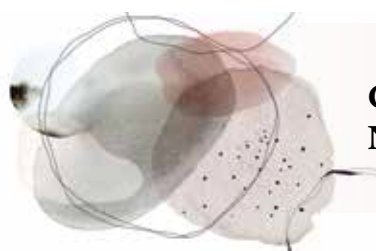
- 4 comidas diarias, a horarios regulares, con la cantidad adecuada.
- Elegir alimentos saludables de todos los grupos alimentarios: lácteos (descremados desde los 2 años), carnes, huevo, legumbres, cereales, semillas, frutas y verduras (variada y completa), y agua potable o segura para consumo.
- Consumir alimentos bajos en grasas trans, y ricos en fibra y omega 3.
- Evitar el agregado de sal y/o azúcar a las comidas.
- Evitar el consumo de ultraprocesados, embutidos, productos de snacks, jugos artificiales y gaseosas que disminuyen el apetito y no aportan nutrientes.
- A esta edad NO se debe consumir carne picada por el riesgo de SUH.
- Evitar té o infusiones de hierbas. No aportan valor nutritivo, e interfieren en la absorción del hierro y pueden ser tóxicos.
- No consumir alimentos pequeños que puedan provocar asfixia (maníes, frutos secos, garrapiñada, etc.). Se pueden ofrecer picados, pisados o molidos.
- No utilizar pantallas al comer.

Es fundamental una **adecuada higiene en la preparación y conservación de los alimentos**. Con respecto a las cantidades, es importante bajar la expectativa de los cuidadores. Confiar en el proceso de hambre y saciedad, y la autorregulación, controlando la evolución del crecimiento físico y la nutrición.

La lactancia prolongada ¿Qué podemos decir los pediatras? ¿Y el destete?: Son ampliamente conocidos e indiscutibles los beneficios de la lactancia humana. Es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños. La OMS, SAP y UNICEF recomiendan lactancia humana exclusiva los primeros 6 meses de vida y luego hasta los 2 años (o más)...

Desde el punto de vista nutricional, no hay una edad en la que la leche humana "NO SIRVA", porque siempre va a aportar probióticos, prebióticos, nutrientes y otros factores de protección inmunológica. El destete tiene que ver con múltiples factores: el rechazo social, las creencias y la cultura, los vínculos y las subjetividades, las redes de sostén, el trabajo, pero sobre todo el deseo personal de quien amamanta, y del lactante o niño.

Para el **destete**, se aconseja que sea paulatino (no abrupto), progresivo y respetuoso de los tiempos y de las voluntades.



Como pediatras, recomendar lo que dice la mejor evidencia, NO juzgar, y acompañar en este proceso de manera respetuosa.

Neofobia y selectividad: Es característica de esta etapa hasta los 3 años. Pueden rechazar alimentos nuevos, o inclusive alimentos que anteriormente aceptaban sin problemas, y muchas veces dejan de lado otros.

¿Qué podemos aconsejar a los cuidadores?

- No obligarlos a comer si no desean. Pero aclarar que esa es la comida que estará disponible, y no otra especial.
- Es importante que no se dejen de ofrecer estos alimentos en forma cotidiana, que la familia los consuma para favorecer su aceptación. Dar el ejemplo.
- No hay premios o castigos con las comidas.
- Considerar el tiempo que estará sentado en la mesa, que generalmente no superan los 20 a 30 minutos.
- Sostener hábitos saludables siempre.

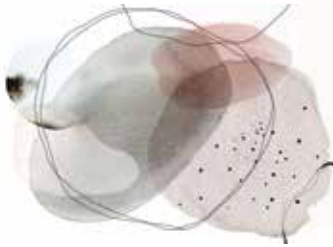
Esto forma parte de un proceso esperable, colmado de aprendizajes y exploración.

¿Y qué pasa con las vitaminas?: No es necesario la suplementación con vitaminas en forma rutinaria a esta edad, cuando la alimentación es **variada y completa**, no hay déficit nutricional ni signos carenciales en el examen físico, ni situaciones especiales que lo requieran. Ante dietas restrictivas, consultar recomendaciones específicas.

Flúor: la fluoración artificial del agua de consumo público sería una medida suficiente, segura y costo-efectiva para la prevención de las caries dentales.

No se recomienda indicar suplementos orales de flúor si el agua de consumo contiene más de 0,6 mg F/l (o más de 0,3 mg F/l en menores de 3 años) o si se cepilla los dientes con pasta que contenga 1.000 ppm de flúor, por aumento del riesgo de fluorosis.

Caries: las caries dentales es considerada una enfermedad azúcar dependiente y está **ligada a la conducta alimentaria y al cepillado dentario**. Una alimentación saludable con bajo contenido de azúcar (sobre todo postprandial), un adecuado hábito de higiene dental y el cepillado con pasta fluorada, así como la salud bucal de los padres (incluso desde el embarazo) son fundamentales para prevenir las caries.



Como pediatras debemos promover cuidados de la salud bucal, y los controles en forma temprana y frecuente con el odontopediatra.

La mamadera o biberón y el chupete: No siempre es necesario utilizar mamadera. Los niños son capaces de tomar en vaso abierto desde edades tempranas. El uso prolongado de la tetina provoca malformaciones en los maxilares, mala oclusión, predispone a caries dental, conlleva un mayor consumo de bebidas azucaradas con bajo valor nutritivo y poco saludables.

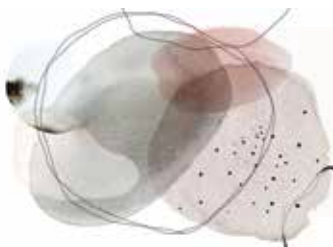
Se recomienda pasar a taza o vaso abierto apenas se pueda: **se aconseja que la mamadera se deje antes de los 18 meses**. Lo mismo se recomienda con el **chupete** ya que su uso prolongado favorece las malformaciones dentarias, otitis, llagas, o infecciones.

El proceso del destete de ambos es similar al pecho.

Juego y juguetes en esta etapa

Jugar estimula las capacidades cognitivas, favorece el desarrollo motor, del lenguaje, la subjetividad y la interacción con las personas, y mientras, están en movimiento. Contar con tiempo disponible para jugar libremente mejora la salud en todos los aspectos.

La curiosidad es el gran motor del aprendizaje, y del conocimiento del mundo que los rodea. De esto se trata el rol social del juego. Ayuda a los niños a relajarse, a controlar sus impulsos agresivos, a expresar lo que piensan y sienten, a hacer amigos, a compartir, a respetar reglas de juego, manejar tiempos y turnos. A tener objetivos y metas a lograr, a superar la frustración, disfrutar y aprender del error.



Observar el juego es una gran herramienta. Preguntar ¿A qué juegan? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quién/es? ¿Dónde?

- A los **2 años tienen juego simbólico**: Imitan todo lo que ven, repiten en forma de juego los actos de la vida cotidiana con juego de roles.
- **Juego paralelo (2 años y más)**, los niños juegan uno al lado del otro de forma independiente, pero sin interactuar entre sí. Juegan con pelotas, rompecabezas, disfraces y elementos de la vida cotidiana para asumir roles (cocinero, mecánico, bombero, doctor, etc.), masas para modelar, etc.

- A los **3 años tienen juego asociativo**: Empiezan a interactuar con otros niños. Hablan entre ellos y comparten materiales, estimulando el desarrollo del lenguaje. Empiezan a mostrar interés por lo que hacen los demás e incluyen a otros en su juego. Es el inicio de su interacción social. Juegan con pelotas, triciclos, libros, autos, figuras de animales, masa, dibujos para pintar, disfraces, casas de muñecas, juegos de agua y arena, etc.
- Entre los **4 y 5 años aparece el Juego cooperativo**: Comprenden y aceptan roles durante el juego, intercambiar ideas y compartir juguetes. También aprenden a respetar la propiedad de otros y a seguir las reglas de cada juego. Juegan con patines, disfraces, cartas, dominó, juegos educativos para aprender palabras y colores, monopatín, etc.

Señales de **ALERTAS** en el juego infantil a estas edades:

- ✓ Dificultad para relacionarse con otros niños.
- ✓ No hay juego simbólico.
- ✓ Siempre repite el mismo juego, sin flexibilidad. Juego rígido.
- ✓ Buscar riesgos excesivos al jugar.
- ✓ Falta de interés por aprender o por jugar, intenso oposicionismo y negación.
- ✓ Movimientos repetitivos, dificultades motrices y del lenguaje.
- ✓ Falta de autonomía progresiva.

Se deben elegir juguetes seguros y acordes a sus preferencias. **Siempre debe haber un adulto disponible**, ya sea para compartir ese momento con ellos, o para supervisar el juego de los mismos y prevenir lesiones no intencionales.

Actividad Física

El movimiento es fundamental para la salud. Según la SAP y OMS, promover actividad física, en total 3 horas diarias repartidas durante el día en esta etapa, en entornos seguros, y reducir los periodos sedentarios, son estrategias clave para desarrollar hábitos saludables que llevarán consigo a lo largo de su vida. ¡Jugar, correr, saltar, bailar etc. es una buena forma!

Sueño

Es un proceso fisiológico que requiere del desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Regulado por el ritmo circadiano, está influenciado por factores endógenos y exógenos, siendo fundamental la rutina de sueño.

A medida que crecen van disminuyendo las horas de sueño nocturno:

- A partir de los 2 años es de 12 horas aproximadamente, con una siesta de 1 hora.
- A partir de los 3 años las siestas van desapareciendo, realizándolas solo cuando la necesitan.
- A los 5 años duermen alrededor de 10 horas.

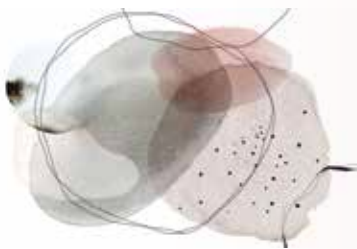
Es importante establecer rutinas a la hora de dormir, evitar pantallas, así como estímulos lumínicos y el ruido. Evitar la actividad física y no consumir bebidas azucaradas en horas previas.

Un sueño reparador en tiempo y calidad influirá en las actividades diarias en forma positiva: favorece la atención, la memoria, la cognición, el razonamiento, la capacidad de autorregular las emociones y controlar las impulsividades, mejora el humor y la creatividad, consolida recuerdos y favorece el aprendizaje. **Dormir bien se aprende...**

Los **problemas del sueño** son frecuentes, y pueden ser expresión de alguna alteración del desarrollo infantil. Generan además gran discomfort familiar:

Insomnio	Es frecuente, generalmente por problemas conductuales. Puede que hayan aprendido modelos poco funcionales, como dormirse en los brazos de los padres o en lugares no habituales. Siempre descartar causas médicas (otitis, hipertrofia adenoidea), etc.
Hipersomnia	A esta edad se manifiesta con hiperactividad, impulsividad y agresividad, así como alteración en la concentración e irritabilidad.
Pesadillas	Son muy frecuentes a partir de los 3 años de edad. Aumentan con el estrés, falta de sueño, fatiga y cambios en el lugar de dormir.
Terrores nocturnos	Se los considera propios del desarrollo, a partir de los 4-5 años. Pueden aumentar por la falta de sueño.
Sonambulismo	Aparece entre los 4-6 años, si bien es más común en niños más grandes.

La evaluación del sueño en cada consulta deberá incluir una historia detallada de las características del sueño, horarios, comportamientos asociados, el ambiente y rutinas. Ver la escolaridad, la socialización, la conducta y las actividades diarias. Interrogar la presencia de crisis familiares, o factores estresantes que puedan estar alterando la dinámica cotidiana del niño/a. También, considerar antecedentes personales y familiares, como interurrencias.



La higiene del sueño es siempre el primer paso para abordar estos problemas. Según cada caso, se podrá indicar psicoterapia, solicitar evaluación por neurología y/o psiquiatría para considerar otras causas, y realizar el tratamiento adecuado.

Jardín de infantes

El ingreso a la escolaridad implica que el niño acepte normas, responda a consignas, regule los impulsos y tenga un desarrollo cognitivo acorde a los objetivos según los niveles. También, es en la escuela donde el niño conocerá realidades distintas a las aprendidas hasta el momento, estimulará su creatividad, la socialización, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, entre otras.

Es crucial el acompañamiento de las familias, docentes y equipo de salud en el aprendizaje sobre todo durante los primeros años de la infancia.

Como pediatras debemos valorar la integración social y el desarrollo de la escolaridad, contemplando también la evaluación del dibujo, la escritura y la lectura en los más grandes.

Cuidando la salud infantil también estaremos promoviendo el cuidado de la educación, otro de los derechos principales de las infancias.

PATOLOGÍAS FRECUENTES

Fimosis

Diferenciar cuando el prepucio del pene no puede ser retraído completamente, de las adherencias balanoprepuciales. Las adherencias asintomáticas y la fimosis puntiforme o estrechez balanoprepucial sin alteración del chorro miccional son fisiológicas, y no deben ser manipuladas antes de los 5 años.

Las maniobras de despegamiento precoz y violento NO deben realizarse a ninguna edad, ya que pueden producir una cicatriz fibrosa, de resolución quirúrgica posterior.

En casos de balanopostitis a repetición, infecciones urinarias o bacteriurias, en especial asociadas a reflujo vesicoureteral se debe realizar la consulta con el urólogo infantil.

Un niño debe tener resuelta su patología del prepucio y ser capaz de higienizarse el glande con el comienzo de la pubertad.

Se debe mantener una higiene con jabón neutro desde el nacimiento, sin lesionar el prepucio. Respetar las causas culturales y religiosas de la circuncisión, que escapa de una indicación médica.

Fusión o sinequia de labios menores

Se presenta entre los 3 meses y los 6 años de edad. Se produce por falta de estrógenos, uso de pañal, vulvovaginitis a repetición o traumatismos reiterados locales. Son benignas y adquiridas, generalmente asintomáticas. Muy pocas veces tienen síntomas urinarios, asociados o predisponiendo a infección del tracto urinario (sobre todo en las sinequias totales o de más del 75%). La mayoría resuelve con tratamiento tópico local.

Sobrepeso y obesidad

Es alarmante el aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad a esta edad. Nuestra responsabilidad como pediatras en cada control implica reconocer aquellos hábitos que conllevan un riesgo en este sentido (alimentación, actividad física, etc.). Poner atención en el aumento del peso del niño en el último año y recitar, conversar con el niño y la familia sobre la importancia de los hábitos de vida saludables de toda la familia para evitar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a futuro.

Problemas del lenguaje

Dislalias: son trastornos de la articulación de palabras, que **no** se deben a lesiones o alteraciones

neurológicas evidentes (disartrias), malformaciones anatómicas (disglosias), sordera (dislalia audiógena) o déficit intelectual.

Es importante considerar el grado de inteligibilidad del habla, así como su adecuación o no al desarrollo evolutivo promedio (la inteligibilidad del habla para desconocidos a los 18 meses es del 25%; a los 2 años, del 50%; a los 3 años, del 75%, y a los 4 años, del 100%).

Disfluencias: un 5% de los niños entre 2 y 5 años pueden tener disfluencias debido a una maduración neurológica más lenta en el procesamiento del habla y del lenguaje. El 80% de ellos se recuperan espontáneamente (las niñas tienen mayor posibilidad de remisión) y el 20% seguirá con tartamudez, persistente en la edad adulta (1% de la población mundial).

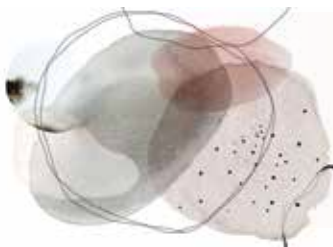
Es fundamental diferenciar, los tipos de disfluencias ya que su abordaje y pronóstico será diferente:

- ✓ Disfluencias evolutivas (normales dentro del desarrollo lingüístico).
- ✓ Tartamudez infantil (bloqueos, repeticiones y prolongaciones acompañadas de tensión, evitación y movimientos asociados en cara y cuello).

La tartamudez, que tiene un origen neurobiológico con un alto componente genético y está influenciada psicosocialmente, pudiendo generar baja autoestima, ansiedad, tics, que requerirán un abordaje interdisciplinario.

Mutismos e inhibiciones: son problemas de comunicación en los que el lenguaje está formalmente intacto y bien desarrollado. “Se tiene, pero no se usa”.

El **mutismo selectivo** se da en determinadas circunstancias, por timidez, o ante personas concretas. Su diagnóstico implica la exclusión de otros trastornos: psicológicos, hipoacusias, retrasos de lenguaje o retraso mental. El niño/a se hace comprender, comprende y se comunica de forma no oral en todos los contextos de su vida cotidiana.



Ante la presencia de alguno de estos trastornos debe solicitarse evaluación por fonoaudiología y ORL para diagnóstico, seguimiento y tratamiento.

OTROS TEMAS PARA ABORDAR EN LAS CONSULTAS

- ✓ Inmunizaciones.
- ✓ El control de esfínteres – enuresis/encopresis.
- ✓ Lectura.
- ✓ Pantallas.
- ✓ Lesiones no intencionales.
- ✓ Sexualidad ¿Qué y cómo hablamos?
- ✓ Estudios complementarios- análisis de sangre y otros.

Inmunizaciones

A los 2 años, en la mayoría de los niños, ya se ha completado el esquema obligatorio de inmunizaciones según el Calendario Nacional de Vacunación de nuestro país.

Es fundamental corroborarlo en cada control, estar atentos a campañas que puedan surgir ante situaciones especiales, e informar a su vez de otras vacunas para epidemias o viajes (dengue, fiebre amarilla, etc.) o que no están en el Calendario Nacional como la anti- meningococo B.

Las vacunas obligatorias para el ingreso escolar se aplican entre los 5 y 6 años, en Argentina son:

- ✓ Triple bacteriana (DTP), que previene la difteria, el tétanos y la tos convulsa.
- ✓ Triple viral (SRP), que previene el sarampión, la rubéola y las paperas.
- ✓ Vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV).
- ✓ Vacuna antivariçelosa.

Control de esfínteres

Alrededor de los 2 años, con una mayor autonomía, mayor desarrollo del lenguaje verbal y de las habilidades motoras, van dejando atrás el oposicionismo y la etapa de oralidad. Es en este momento donde empiezan a dar **señales que nos muestran interés por controlar esfínteres**: pueden permanecer más tiempo con el pañal seco, les molesta tener el pañal sucio, también se sacan los pañales, avisan cuando ya hicieron pis o caca, etc. Para lograr el control de esfínteres no sólo es necesaria una maduración. También es necesario que la familia y cuidadores se involucren y acompañen este proceso que implica, además, el aprendizaje social de hábitos (como la higiene) y costumbres específicas de cada cultura. Es fundamental que no haya otras exigencias o situaciones estresantes para el niño. El control de esfínteres puede ser considerado precoz cuando se realiza antes de los 18 meses y tardío, después de los 36 meses.

¿Cuáles son las etapas del control de esfínteres?

1. El niño es capaz de percibir que hizo pis o caca en el pañal, y es capaz de decirlo: "me hice pis".
2. Puede percibir y transmitir que está por hacerse pis o caca pero aún no puede retener y controlarlo: "me estoy haciendo pis". (No llega al baño aún).
3. En la última etapa, puede retener y decidir la expulsión de pis o caca, situación que le da placer. Puede interrumpir y recomenzar: "quiero hacer pis". Quiere, va al baño, y decide expulsarlo de forma controlada.

Para el niño, sus excreciones son un tesoro precioso y las usa como "regalo" para mostrar su afecto u hostilidad hacia sus padres. **La función anal va unida a situaciones de poder y seguridad**, y muchas veces es usado para "llamar la atención". Esto es reemplazado por arena, barro, masas, plastilina, etc. Por eso en esta etapa eligen jugar a hacer tortas, chapotear en el agua, trasvasar líquidos, modelar masas, etc.

Algunos consejos para acompañar el proceso:

- Se puede ofrecer pelela o adaptadores de inodoro, o similares, si son necesarios.
- Comenzar con el control diurno. El nocturno puede retrasarse un mes aproximadamente.
- Estimular el proceso si ya hay señales, estar atentos ante el pedido para ir al baño.
- Cuando deciden dar el paso de “sacar el pañal” es porque el niño ya está preparado para hacerlo. Una vez logrado este cambio, debe ser total y sostenido. Las inseguridades de los padres pueden generar mayor dependencia en los niños.
- Al principio puede haber situaciones que generen retrocesos transitorios.
- No castigar ni retar. Respetar los tiempos propios de cada niño. No apurar etapas.

El niño puede atravesar diferentes emociones, desde sentirse feliz y orgulloso por los logros, hasta molestarse cuando se ensucia o se moja. Es común que aparezca miedo, vergüenza, etc., que deben ser respetadas sin presionar ni invalidar. Es esperable que en la etapa de lograr el control de esfínteres sucedan episodios de pérdidas de orina, sobre todo cuando están ensimismados en su juego.

Asesorar a los padres sobre el momento evolutivo del niño y anticiparnos a las etapas del control de esfínteres es fundamental para el éxito en el logro y en el sostenimiento de este gran hito madurativo. Nunca olvidar que “los pañales no se sacan, se dejan”.

Enuresis: es la pérdida involuntaria de orina, diurna o nocturna, en un niño mayor a 5 años de edad cronológica. Debe manifestarse con una frecuencia de al menos 2 episodios semanales durante por lo menos 3 meses consecutivos, o por malestar evidente o que repercuta en lo social.

Encopresis: es la evacuación repetida de heces en lugares inadecuados. (Ejemplo, ropa o suelo), sea voluntaria o involuntaria, en niños mayores de 4 años de edad cronológica. Al menos debe presentarse un episodio por mes y durante, como mínimo, tres meses. Se puede presentar con constipación e incontinencia por rebosamiento, o sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento.

Ante estas situaciones de enuresis y encopresis es importante siempre conversar con el niño:

- Investigar hábitos, factores estresantes ambientales, las expectativas de los padres en relación al control de esfínteres que puedan estar generando ansiedad.
- Indagar acerca de las experiencias de sus padres en su propio control de esfínteres.
- Valorar en la consulta la presencia de otros síntomas y signos clínicos que acompañan, o comorbilidades.

Lectura

Es importante promover hábitos saludables en cada consulta. La lectura de cuentos es una actividad ideal, y que tiene muchos beneficios: estimula la creatividad, ejercita la memoria, transmite conocimientos y valores de generación en generación. Leer un cuento en las noches antes de dormir ayuda a conciliar el sueño y fomenta el apego. Estimula el desarrollo del lenguaje y el aumento del repertorio de palabras. Fomenta en la escucha la atención, facilitando la comunicación. Promueve el maravilloso hábito de la lectura recreativa desde pequeños. **A través de este hábito**

de lectura hay un tiempo de calidad que se comparte con el niño, lo que fomenta vínculos fuertes y grandes beneficios emocionales para toda la vida.

Pantallas

Si bien hoy los niños son nativos digitales, y tienen a disposición diferentes tecnologías en forma natural, tenemos que tener en cuenta varias cosas: el uso excesivo de pantallas tiene un impacto negativo en el desarrollo neurológico de los niños/as pequeños, afectando habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje, y socioemocionales.

Pueden generar grandes repercusiones en el aprendizaje, en la memoria y la atención, provocando problemas de conducta y menor rendimiento escolar.

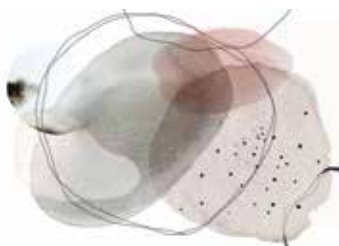
La evidencia muestra que la exposición temprana y prolongada a medios electrónicos está asociada con un mayor riesgo de padecer aislamiento social, déficit en la atención, ansiedad, hiperactividad, problemas del sueño, y depresión. Además, interfiere en la socialización, desplaza el tiempo de juego al aire libre, pudiendo afectar negativamente el lenguaje.

- **La SAP recomienda que entre 2 y 5 años no se expongan más de 1h 30min a pantallas por día, siempre acompañados por un adulto que pueda interactuar, seleccionar e interpretar los contenidos que están consumiendo. Elegir contenidos interactivos que fomente el aprendizaje. La Asociación Española de Pediatría en su última recomendación (2024) menciona cero pantallas hasta los 6 años de edad.**
- Evitarlas a la hora de dormir y en horas previas. No deben estar presentes en las comidas.
- Es importante fomentar que los adultos cuidadores puedan adquirir herramientas e informarse en las nuevas tecnologías para así acompañar a las infancias para un uso adecuado, crítico y saludable en el futuro.

Lesiones no intencionales

Éstas representan un serio problema de salud en la Argentina y el mundo, ocasionando numerosas muertes, lesiones graves y consultas. **Las más comunes en la infancia son las producidas en el hogar, y las automovilísticas.**

- En el **hogar**, los lugares más peligrosos son: la cocina, el baño, las escaleras, ventanas y balcones, y el patio o jardín y la pileta, cuando existe. Pueden producirse caídas y traumatismos, heridas, ingesta de cuerpos extraños y quemaduras. También los ahogamientos por inmersión, intoxicaciones (por ingesta de productos de limpieza, medicamentos o por monóxido de carbono entre otros), y electrocución.



La mejor prevención es la supervisión permanente de un adulto responsable. Un minuto sin “vigilancia” puede ser suficiente para generar una situación de riesgo.

- Para el **viaje en auto**, en esta etapa se debe usar un Sistema de Retención Infantil (SRI), y viajar en el asiento trasero de los automóviles. Existen distintos modelos de SRI, que se diferencian en la edad y el peso que toleran del niño, la protección lateral, el sistema de anclaje al automóvil y calidad de los materiales. (Ver Consenso sobre mobiliario infantil seguro de la SAP).

Sexualidad ¿qué y cómo hablamos?

Esta es una etapa de mucha curiosidad por conocer su propio cuerpo, y las diferencias con otros niños y niñas. Pueden aparecer conductas autoexploratorias y estimulatorias (masturbación), que los ayudan a descubrirse, y les generan placer. Esto es algo esperable para la edad. También querrán conocer el cuerpo de otros mediante el juego. Este es un buen momento para enseñarles el respeto por la intimidad propia y ajena. Y es importante que aprendan las partes del cuerpo y sus funciones.

Conductas como: tocarse los genitales en público o en privado, mostrar los genitales a un amigo/a, tratar de ver desnudo a un compañero o adulto, ponerse muy cerca de otro/a, son esperables entre los 2 y los 6 años. Son transitorias, poco frecuentes y no alteran la vida diaria.

Señales de **ALERTAS en el comportamiento sexual** a esta edad incluyen actos que:

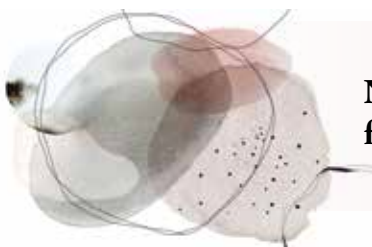
- ✓ Ocurran con frecuencia y no se puedan desviar.
- ✓ Provoquen dolor físico o emocional, o lesiones a sí mismos o a otros.
- ✓ Se asocien con agresión física.
- ✓ Impliquen coerción o fuerza.
- ✓ Simulen actos sexuales de adultos.

Evaluar las características familiares y de cuidadores: desnudez de la familia, jardines maternos o jardín, nuevo hermanito/a, hábitos y estilos de crianza de las familias.

Tener presente el abuso, la negligencia y el maltrato, y ante la sospecha informar al servicio de protección infantil local.

Es importante promover conductas de autocuidado del cuerpo desde edades tempranas. Cuidar el contenido de las pantallas. Fomentar el diálogo, haciéndoles saber que siempre van a ser escuchados y valorar la palabra de los niños.

Estudios complementarios - Análisis de sangre y otros

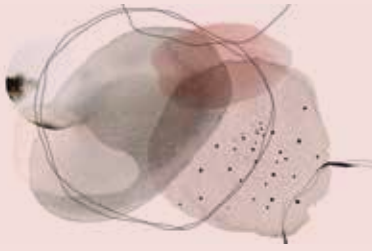


No son necesarias las pesquisas con análisis de sangre en forma rutinaria a esta edad.

Se reservarán en situaciones especiales, según antecedentes personales, familiares y hallazgos en el examen físico o interurrencias de enfermedades. Ejemplo: **dislipidemia**: podría considerarse si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz (<55 años en los hombres y < 65 años en las mujeres) o en niños con otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, etc.

RECOMENDACIONES AL FINAL DE LA CONSULTA

- Sentarse frente a la familia y conversar.
- Hacer una síntesis acerca de la salud del niño.
- Promover acciones de vida y alimentación saludables.
- Dar un espacio a los padres para hacer preguntas.
- Dar pautas de alarma y medidas generales de prevención.
- Acordar si es necesario por los problemas planteados, la próxima cita.



Autoevaluación

I. Lea cada enunciado y señale V si considera que es verdadero y F si es falso.

	V	F
1. Se recomienda hacer controles en salud cuatrimestrales entre los 2 y 3 años.	☐	☐
2. El crecimiento físico se acelera en los niños entre los 2 y 5 años.	☐	☐
3. El uso prolongado de mamadera puede causar malformaciones, caries, y consumo excesivo de bebidas azucaradas.	☐	☐
4. La regulación emocional en los niños pequeños depende inicialmente de los cuidadores.	☐	☐
5. Un niño que mantiene el uso de chupete más allá de los 2 años está en mayor riesgo de otitis y problemas dentarios.	☐	☐
6. Las disfluencias del lenguaje entre los 2 y 5 años pueden indicar una tartamudez con alta probabilidad de persistencia.	☐	☐
7. El juego cooperativo suele observarse por primera vez entre los 2 y 3 años de edad.	☐	☐
8. A los 3 años, el juego asociativo comienza a reemplazar el juego paralelo.	☐	☐
9. La presencia de adenopatías palpables cervicales en un niño debe ser motivo de derivación inmediata.	☐	☐
10. Los instrumentos de pesquisa del desarrollo, como PRUNAPE o IODI, son diagnósticos si dan resultado positivo.	☐	☐
11. La suplementación con flúor es recomendable en todos los niños para prevenir caries.	☐	☐
12. La aparición de caries a esta edad está principalmente relacionada con la predisposición genética.	☐	☐
13. La evaluación del lenguaje debe considerar la comprensión, expresión, y pronunciación del niño.	☐	☐
14. La actividad física recomendada para niños de 2 a 5 años es de al menos 1 hora diaria.	☐	☐
15. La neofobia alimentaria es normal en esta etapa del desarrollo	☐	☐

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

LUCA, 2 AÑOS Y 3 MESES

Relea el caso de Luca y revise sus respuestas.

a) ¿Hasta qué edad pueden desencadenarse?

.....

.....

b) ¿Qué información es importante de la anamnesis?

.....

.....

c) ¿Qué sugerencias podemos brindar a los padres ante un berrinche?

.....

.....

d) ¿Se pueden prevenir?

.....

.....

CAMILA, 4 AÑOS

Camila, sin antecedentes previos de importancia. Control de esfínteres diurno y nocturno a los 2 años y medio. Acude por presentar escapes de orina casi todas las noches al dormir, en los últimos 3 meses. Los padres no han observado ningún otro síntoma asociado y están preocupados, por lo que volvieron a ponerle pañales para dormir.

a) ¿Cómo orientaría la anamnesis y qué priorizaría en el examen físico?

.....

.....

b) ¿Qué recomendaciones daría?

.....

.....

CONCLUSIONES

La niñez es una época de crecimiento y cambios rápidos. Los niños son sujetos de derechos, por lo que todos, sin excepción, deberían realizarse controles en salud periódicos desde una mirada integral.

Realizar un control en esta etapa brinda la oportunidad para promover hábitos saludables, prevenir y detectar precozmente enfermedades a través de una anamnesis completa, un examen físico detallado que incluya la valoración del crecimiento físico, la nutrición, la maduración y el desarrollo en todas sus áreas, además de promover un vínculo confiable entre el pediatra y la familia.

La salud infantil es responsabilidad de todos. Y nosotros, los pediatras, debemos tener un rol de acompañamiento hacia las familias en este proceso de cuidado integral.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Calendario Nacional de vacunación Argentina. 2025. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025_01_calendario_nacional_vacunacion.pdf
- Guía para el seguimiento del desarrollo infantil en la práctica pediátrica. Arch Argent Pediatr 2017; 115(3):304.
- Guía del Ministerio de Salud de Nación. Salud y alimentación en la primera infancia. 2023.
- -IODI <https://www.google.com/url?q=https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2022-05/iodi2022.pdf&sa=D&source=docs&ust=1737552444342273&usg=AOvVaw3rsA1CvXZO7-ygXpCmzpSd>.
- Validación de un formulario para la detección de niños con alto riesgo de padecer trastornos del desarrollo. Cuestionario PRUNAPE pre-pesquisa. Lejarraga y cols. Arch Argent Pediatr 2013;111 (6)476-483.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea cada enunciado y señale V si considera que es verdadero y F si es falso.

1. Verdadero.
2. **Falso.** A partir de los 3-4 años, el crecimiento se hace más lento, con menor aumento de peso y cambio en la forma corporal.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. **Falso.** El 80% de las disfluencias en esta etapa son evolutivas y transitorias; solo un 20% evoluciona a tartamudez persistente.
7. **Falso.** Surge entre los 4 y 5 años; antes predominan juego paralelo y asociativo.
8. Verdadero.
9. **Falso.** Deben evaluarse características como tamaño, movilidad y otros hallazgos clínicos antes de derivar.
10. **Falso.** Son herramientas de detección que requieren evaluación posterior.
11. **Falso.** Solo si el agua tiene baja concentración de flúor ($<0,3$ mg/l en menores de 3 años).
12. **Falso.** La dieta azucarada, higiene bucal y hábitos son los principales factores.
13. Verdadero.
14. **Falso.** Se recomienda un total de 3 horas diarias, distribuidas a lo largo del día.
15. Verdadero.

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

LUCA, 2 AÑOS Y 3 MESES

- a) **¿Hasta qué edad pueden desencadenarse?** Hasta los 3 años y medio aproximadamente.
- b) **¿Qué información es importante de la anamnesis?** Recabar información sobre la presencia de crisis familiares, situaciones estresantes, cambios, etc. Frecuencia, duración, intensidad de los episodios, que hacen los padres.
- c) **¿Qué sugerencias podemos brindar a los padres ante un berrinche?**
Para acompañar esta emoción fuerte las personas adultas deben estar en calma, brindar contención y no poner el foco en lo que lo desencadenó.
Se aconseja generar alguna distracción para **cambiar el foco de atención**.
Si la situación lo amerita se les puede dar la posibilidad de **elegir entre 1 u otra cosa**. Es aconsejable **NO CEDER** (no acceder a darle lo que quería).
- d) **¿Se pueden prevenir?**
Evitar situaciones que lo desencadenan, anticiparse, límites respetuosos. Si ya sabemos qué situación lo frustra, **tratar de evitarla**.

La PUESTA DE LIMITES RESPETUOSOS implica establecer normas y expectativas claras, tanto para padres como para los niños, de manera que se protejan los derechos y necesidades de todos, y sin dañar la relación. Esto se logra comunicando estas expectativas manteniendo la calma, sin violencia, pero con firmeza.

CAMILA, 4 AÑOS

a) ¿Cómo orientaría la anamnesis y el Examen físico?

Preguntar sobre problemas emocionales en los últimos meses. Valorar cambios en los hábitos de vida de la niña. Buscar alteraciones en la forma de orinar. Preguntar acontecimientos familiares o sociales adversos. Como es la rutina de sueño o el momento de dormir. Ingesta de líquidos por la tarde y noche.

¿Hay síntomas diurnos? ¿Encopresis? Como fue el control de esfínteres en sus padres.

Evaluar sinequias vulvares, lesiones locales en relación a síntomas urinarios y otros signos de importancia, ejemplos hematomas, excoriaciones, etc.

b) ¿Qué recomendaciones daría? Disminuir los líquidos desde la tarde-noche. Rutinas e higiene del sueño. No usar pañal nuevamente.

